



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : فايزه احمد فرج نوح
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : الهرم
رقم البطاقة : 27902012101801 رقم التليفون : 01129099945
العنوان : ----
العمر (تاريخ الميلاد) : 01-02-1979 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 20-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.
تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: فايزه احمد فرج نوح National ID: 27902012101801	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

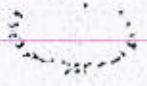
تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





Patient Name : الأستاذ / فايزه احمد فرج
Patient No. : 27902012101801
Path No. : 2384/23
Sex : Female
Age : 44 Y
Referring Doc :

Request No. : 13003444
Request Date : 27/07/2023
Verification Date : 12/08/2023
Financial Category : نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data : Right breast cancer post NACT

History of the specimen : Right WLE & Right ALN biopsy .

Gross Examination:

The specimens were received :
The WLE specimen measured 13 x 10 x 6 cm , covering skin ellipse measured 8 x 3.5 cm .
The section revealed 2 wired areas :
The first area was well defined greyish white firm tumour bed site measured 2 x 1.5 x 1.5 cm , near the medial margin (0.3 cm) .
The second area was an ill defined rubbery greyish white tumour bed site measured 3 x 2 x 1 cm , near the medial margin .
The ALN biopsy : A fibrofatty tissue measured 5 x 5 cm enclosing 12 ALNs
Frozen section: Free margins

Microscopic examination:

Pathological type: Pathological complete response
Invasion: No
Lymph node involvement: Free ALNs (0/12)
Section Margins: Free margins
Pathologic response to therapy: Pathologic complete response

Diagnosis:

Wide local excision & Right ALN biopsy :
No detectable tumor in breast tissue
Free margins
Free SLNs (0/12)
Pathologic complete response

Verified by :
Dr. Heba Hasan

Date : 23/08/2023 11:28:26

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



قسم الباثولوجي

السن : 46 سنة

(2024) (3164 - 2024)

تاريخ الإسلام : 2024/11/27

اسم المريض : فائزة احمد فرج

محول من :

تاريخ الحضور : 2024/11/18

NATURE OF SPECIMEN :

Endometrial curette.

GROSS :

Multiple tan brown tissue fragments measured collectively 1.5x1.5cm, totally submitted.

MICROSCOPY :

Sections examined revealed endometrial tissue formed of small tubular focally dilated glands lined by focally stratified columnar epithelium among spindle cell stroma with focal decidualization and edema.

Ectocervical tissue could be also seen.

No dysplasia or malignancy in sections examined.

AGNOSIS :

Endometrial curette;

DISORDERED PROLIFERATIVE ENDOMETRIUM.

COMENDATION :

Prof. Dr. Rasha Farouk, MD.

Dr. Dina Medaht, MSc.



Ministry of Health and Population
Kingdom of Saudi Arabia

الوزارة العامة للصحة
والسكان



A-Patient ID:
1- Name: **البراهيم احمد لرج**
2-ID number: **27902012101801**

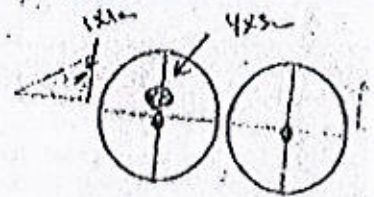
Sex:

MDT form
3- Medical number:
Female

63125931
Old Med:

Patient Age: 44 Y

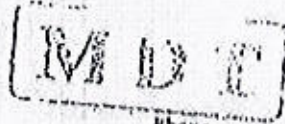
536/2023



Family history

Marital status

Co morbidity



Phone

HR Score

Menopausal
status

01129099945

BMI

GROUP

A

REASON OF MDT NEW

Date of MDT 03/01/2023

Breast Imaging:

Clinical data

Mets Workup:

US AP-->FREE,, CHEST XRAY-->FREE

DX:

ER:

B/B

PR:

4/8

Her 2 Neu:

+VE

SISH:

K107:
22%

RT TOC REC (1/23)

1

2

H

1

H

0

Sonomammography

RT multifocal malignant masses (central quadrant 47x32mm)
11-12 o'clock 36x27mm

9 o'clock 11x6 mm

Single axillary lymph node level I

PATIENT HISTORY

• Bone scan: Free

• CAP CT: Free

MDT OUTCOME & PLAN

For clip insertion in both masses then start NACTH (TCHP X6 cycles)
with GCSF support followed by WLE & SLNB according to response with new BSM

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

Psychiatric

SIGNATURE

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Nutrition

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]



Patient Name: Faiza Ahmed Farag Nouh	Date : 13/02/2025
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 20023/536	Pat. ID: 29100

**NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**

Reviewing the previous study dated 23-2-2023

1. Chest:

- Interval right CBS is seen
- Right apical pulmonary nodule measures about 3 mm
- Right upper and left fissural pulmonary nodules , the larger measures about 5 mm.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged in size with hypodense CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities on non-contrast basis.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

3. The scanned skeleton:

- The scanned skeleton shows scanned part of proximal left femur shows abnormal remodeling and heterogenous texture
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.



Patient Name: Falza Ahmed Farag Nouh	Date : 17/02/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 536/2023	Pat. ID: 29100

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH
RESOLUTION ULTRASOUND**

Indication:

Right breast conserving therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)

Right breast:

- Operative bed parenchymal distortion and scarring with no sizable mass
- No suspicious mass lesions, micro calcifications
- No sizable collection
- Diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- No regional lymphadenopathy

Left Breast:

- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- No spiculated mass
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post right BCS status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal study of the left breast (BIRADS 1)

Dr. Mohamed Mofsen, M.D.



جهة الإصدار: لمرج الجبيلة

تاريخ الإصدار: 2023-2-23

إلى من يهمه الأمر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تسلم من خلال قوانين منظمة للاحتجاج الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 "الأطفال دون السن المشرقة" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعولة وطبقاً للقاعدة البيوتات المرسلة من التأمينات الاجتماعية وطبقاً لقاعدة البيوتات المرسلة من الضمان الاجتماعي والبحث تدبر أن

السيد (ة) فائزة احمد فرج بطاقة رقم 27902012101801
وطبقاً الى خطاب من التأمينات الاجتماعية ولقد عدم الانتفاع
باعتبار من الفئات غير المنفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون اي مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكراً



القاعدة مركز نظم المعلومات
ودعم



الخطاب مدلى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حالة المواطن من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الشريعة و التعليم

الإدارة المركزية للتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار



Patient Name: Faizza Ahmed Farag
Prof. Dr: Center harmal
Accession: 230227219

Patient ID: 573705
Exam Date: 27/2/2023

^{99m}Tc-MDP BONE SCAN

Ordered information: skeletal surveying.

Technique:

Anterior and posterior Delayed Whole body bone scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP:

Report:

Delayed static phase :-

- 1 Degenerative changes are noticed in the dorsal and lumbar vertebrae as well as both knee joints, more advanced at DV10.
- 2 Left femoral bone deformity is seen with mild shortage of the left lower limb.
- 3 There is no hot spot that account for osseous deposits could be detected all over the surveyed skeleton
- 4 Both kidneys are visualized.

Conclusion:

surveyed skeleton is free from definite osseous deposits.

Thanks;
Nuclear Dr. Huda Fathy, MD

5669

000010144 000010144 000010144 000010144 000010144 000010144 000010144 000010144 000010144 000010144